

Universidad de Ciencias Pedagógicas

Enrique José Varona

Facultad: Educación Infantil. Dpto Educación Especial

Carrera: Logopedia

***Título: Estrategias de comunicación aumentativa en
la educación de los niños con sordoceguera de la
primera infancia***

Trabajo de diploma

CD. 5to año

Autora: Elisabeth de las Mercedes González Negrín

Tutora: Dr. C. Xiomara Rodríguez Fleitas

Profesora Titular, UCP EJV

La Habana, 2014

ÍNDICE

PÁG.

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO	9
Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la comunicación aumentativa en las personas con sordoceguera.	
1.1. La comunicación aumentativa en las personas con discapacidad desde el enfoque histórico cultural.	9
1.2 La comunicación aumentativa como vía para la atención educativa a niños con sordoceguera de la primera infancia.	15
1.3 Particularidades de las estrategias de comunicación aumentativa en niños con sordoceguera de la primera infancia.	21
2. Presentación de la propuesta. Estrategias de comunicación aumentativa para la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia.	25
2.1 Operacionalización de la variable. Dimensiones e indicadores.	28
2.2 Análisis del proceso y los resultados del diagnóstico inicial.	
2.3 Fundamentación de la propuesta.	30
2-3.1 Estructura y diseño de la propuesta. Sus particularidades en los niños con sordoceguera de la primera infancia.	
2.4 Valoración de los resultados de la aplicación de la propuesta.	
CONCLUSIONES	32
RECOMENDACIONES	33
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

Resumen

La presente investigación aborda una temática de gran interés para la educación especial, como parte de las transformaciones que se realizan para elevar la calidad educativa en la especialidad de sordociegos. Se trata el desarrollo de los sistemas de comunicación aumentativa como base para elevar la calidad de vida de estas personas.

El contexto de la investigación fue la escuela especial William Soler Ledea, del municipio La Lisa, en La Habana. Se realizó un estudio de caso, el que se combinó con un pre-experimento para constatar las necesidades y potencialidades de una niña con sordoceguera que se beneficia del implante coclear. Además, se aplicaron entrevistas, encuestas y observaciones para precisar el diagnóstico de la realidad.

A partir de las indagaciones teóricas y empíricas constatadas, se proponen estrategias de comunicación aumentativa para favorecer la educación de estas personas y su inclusión social, así como la orientación a la familia para la continuidad del proceso educativo, en función de su desarrollo personal y social.

Present it investigation tackles a subject matter of great interest for especial education, like part of the transformations that they make for raise the educational quality in deaf-blind's specialty. The development has to do with the systems of augmentative communication, like base to raise these people's quality of life itself. The context of investigation was the especial school William Soler Ledea, of the municipality The Lisa, in Havana.

They intend strategies of augmentative communication to favor these people's education and his social inclusion, as well as orientation to the family for the continuity of the educational process, in terms of his personal and social development.

INTRODUCCIÓN

La educación de las personas con discapacidad constituye un reto para los sistemas educativos en el mundo. En Cuba, se le da especial atención y se caracteriza por su esencia pedagógica, humanista y optimista; con un alcance extraordinario en los últimos tiempos, en aquellos niños con necesidades educativas más complejas como la sordoceguera.

La necesidad de ofrecer una atención educativa que se acomode a las necesidades y potencialidades de estas personas, a partir del respeto y el derecho que tienen de disfrutar de una vida digna como los demás, exige de la búsqueda de vías que contribuyan a tales propósitos. Por eso, se profundiza en el empleo de diversas estrategias de comunicación aumentativa.

En la atención educativa a personas con sordoceguera, adquiere particular significación el empleo de los sistemas de comunicación aumentativa para el acceso al mundo que le rodea, con el aprovechamiento de todos los sistemas funcionales sensoriales, el movimiento de su cuerpo para desplazarse, sus brazos para alcanzar, sus manos para tocar y agarrar y los dedos para recoger información precisa sobre las características de los objetos. Nos sirve de referencia para valorar la significación del tema que se presenta, por el lugar que ocupa la comunicación en la formación de la personalidad como base de la educación.

En la actualidad de los Sistemas de Comunicación Aumentativos (SCA) han alcanzado gran auge por su impacto en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de las personas que presentan severas dificultades en la comunicación, en particular, aquellas que tienen un diagnóstico de sordoceguera. En las observaciones realizadas en la práctica pedagógica, se ha constatado la siguiente situación problemática, la que evidencia situaciones no resueltas, ellas son:

- Carencias teórico-metodológicas en la aplicación de los sistemas de comunicación aumentativa en niños con diagnóstico de sordoceguera.
- Dificultades en la atención educativa al niño con sordoceguera como especialidad única, se transpolan experiencias de los niños sordos y ciegos.
- Insuficiencias en la orientación educativa a la familia para el desarrollo de la comunicación en los niños con sordoceguera.

Esta situación presentada en la práctica pedagógica permite plantear el siguiente **problema científico**: ¿Cómo contribuir al desarrollo de los sistemas de comunicación aumentativa en la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia? Para dar solución al problema científico se presenta el siguiente **objetivo**: Proponer estrategias que contribuyan al desarrollo de la comunicación aumentativa en la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia.

Para seguir la lógica de la investigación se precisan las siguientes **preguntas científicas**:

- ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan la comunicación aumentativa en la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia?
- ¿Cuál es el estado actual de la comunicación aumentativa de una niña con sordoceguera de la primera infancia?
- ¿Qué particularidades deben poseer las estrategias de comunicación aumentativa que contribuyan a la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia?
- ¿Qué resultados se obtienen en la aplicación de las estrategias de comunicación aumentativa a una niña con sordoceguera de la primera infancia?

En este trabajo se siguen las **tareas de investigación** que se señalan a continuación:

- 1- Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la comunicación aumentativa en la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia.
- 2- Caracterización del estado actual de la comunicación aumentativa de una niña con sordoceguera de la primera infancia, de la escuela especial William Soler Ledea.
- 3- Diseño de estrategias de comunicación aumentativa que contribuyan a la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia.
- 4- Valoración de los resultados que se obtienen con la aplicación de las estrategias de comunicación aumentativa.

En la tesis se utiliza una estrategia de investigación basada en la dialéctica materialista, donde se combinan los métodos cuantitativos y cualitativos, en las indagaciones **teóricas y empíricas**:

- Análisis y síntesis; con el fin de analizar la información de diferentes fuentes bibliográficas y los resultados de los métodos empíricos empleados para la interpretación y procesamiento de los resultados del tema que se investiga.
- Inducción y deducción; para realizar las generalizaciones y abstracciones necesarias en función de las regularidades de las estrategias de comunicación aumentativa en los niños sordociegos.
- Modelación; para la abstracción mental de los elementos esenciales que distinguen las estrategias de comunicación aumentativa en la atención educativa a los niños sordociegos como discapacidad única.
- Análisis documental; para recoger información acerca de la comunicación aumentativa en la especialidad de sordociegos.

- La exploración logopédica como técnica, que permite precisar el estado del desarrollo del lenguaje y la comunicación de la niña investigada.
- Observación científica; con el propósito de constatar la utilización de los sistemas de comunicación aumentativa de los niños sordociegos.
- Entrevista a maestros y especialistas; para constatar la preparación acerca de los sistemas de comunicación aumentativa de los niños sordociegos.
- Entrevista a la familia de la niña sordociega para comprobar la orientación y seguimiento acerca de la comunicación aumentativa utilizada.
- Estudio de caso; con el propósito de profundizar en el diagnóstico e intervención del niño sordociego a partir de la aplicación de los sistemas de comunicación aumentativa. En él se valora de manera cualitativa las transformaciones que se producen en la atención educativa de este.
- Consulta a especialistas; con el fin de valorar la propuesta elaborada para su perfeccionamiento antes de su aplicación.
- El pre-experimento; para constatar en la práctica pedagógica los cambios producidos con la aplicación de la propuesta, con respecto al diagnóstico inicial.

Métodos Matemáticos-Estadísticos:

- El análisis porcentual como método estadístico-matemático para el procesamiento de la información en el diagnóstico inicial y final.

Grupos de estudio:

Grupo A: Está conformado por una niña con diagnóstico de sordoceguera de la escuela especial William Soler Ledea. Ella tiene 5 años de edad, se beneficia de la tecnología educativa implante coclear y es atendida desde los 2 años en esta institución.

Grupo B: Está formado por 5 maestros y 5 especialistas. El 100% son licenciados en Educación Especial y 3 son master en esta especialidad. Sus edades oscilan entre 30 y 52 años y su experiencia como docentes entre 3 y 11 años.

Grupo C: Está formado por la familia de la niña con diagnóstico de sordoceguera, de la referida escuela. Se trata de un medio familiar funcional, compuesto por madre, padre, hermano y abuelos maternos.

Actualidad científica:

Se revela en el hecho de tratar una problemática de la escuela de práctica, la que se vincula al proyecto de investigación del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial: Atención educativa a las personas con necesidades educativas especiales en el área de la comunicación. Sus resultados contribuyen al perfeccionamiento del modelo pedagógico dirigido a niños con sordoceguera. Las estrategias de comunicación aumentativa que propone constituyen herramientas para el trabajo metodológico de la institución educativa.

La investigación consta de: introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 8 anexos que complementan el estudio realizado. En la introducción, aparece el diseño teórico-metodológico que orienta la lógica investigativa, se señala la actualidad científica, así como su pertinencia social. En el desarrollo, se abordan los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de la comunicación aumentativa para la atención educativa a los niños sordociegos de la primera infancia; se precisa la situación actual del problema que se investiga y la propuesta de estrategias de comunicación aumentativa que respeten las particularidades de esta especialidad. También se señalan las conclusiones y las recomendaciones.

Este trabajo ha sido presentado en diferentes jornadas científicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, recientemente en el evento base Pedagogía' 2015, en una mesa redonda acerca del empleo de los sistemas de comunicación aumentativa en las personas con discapacidad.

DESARROLLO

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN LAS PERSONAS CON SORDOCEGUERA

1.1. La comunicación aumentativa en las personas con discapacidad desde el enfoque histórico cultural.

En la actualidad, con frecuencia se habla de comunicación alternativa y/o aumentativa para la atención a los trastornos severos de la comunicación, donde se dificulta el canal oral por diversas causas, sin embargo, se coincide con Torres S. (2001:25), quien prefiere referirse a la comunicación aumentativa (CA), al expresar que se trata de un concepto más amplio, el que incluye todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar para facilitar la comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la ejecución del habla. Se trata de aumentar ciertos aspectos, no siempre los mismos del proceso comunicativo.

Estos sistemas están dirigidos a desarrollar la capacidad de comunicación, aunque principalmente, han sido diseñados para incrementar el habla y establecer una comunicación más fluida e inteligible. Lo importante es posibilitar a personas con discapacidad por causas sensoriales, físicas o psíquicas; la interacción con el mundo, no importa el medio que se emplee, ni su clasificación.

Una de las discapacidades donde más se ha sistematizado estos sistemas es precisamente en las personas sordas, haciendo uso de la lengua de señas, la que constituye la primera lengua de la comunidad sorda, reconocida como su patrimonio cultural.

Los *sistemas de CA* permiten representar y comunicar funcionalmente lo que se quiere significar de manera espontánea y generalizable. Sus principales objetivos están dirigidos a: ampliar los canales de comunicación social, en función del

mejoramiento de su calidad de vida; desarrollar las potencialidades de las personas con discapacidad y aumentar las posibilidades de autonomía personal con la utilización de nuevas estrategias.

Entre los principales usuarios de la CA se destacan: algunos sordos profundos, sujetos con parálisis cerebral, personas con retraso mental severo, en casos de espectro autista y casos de discapacidades múltiples como la sordoceguera. Es importante conocer la forma en que se clasifica la CA para realizar una correcta selección y/o combinación de los diferentes sistemas al ser utilizados para satisfacer las demandas de sus usuarios.

Los sistemas de comunicación aumentativa se clasifican en dos grupos: *sin y con apoyo externo*, en coherencia con los usuarios y la selección de los sistemas. Los SCA sin apoyo, surgieron como ayudas para desarrollar el lenguaje y el habla. Estos sistemas *no utilizan soportes externos* al sujeto para comunicarse, son más manejables, dinámicos, autónomos y económicos y exigen mayores capacidades cognitivas. Los referidos sistemas, pueden presentarse *sin ayuda externa al sujeto* y con ayuda externa, en dependencia de la necesidad de usar elementos ajenos al propio sujeto que se comunica.

Los sistemas **sin ayuda externa**, son sistemas organizados que se remontan a varios siglos atrás. Surgieron como ayudas para desarrollar el lenguaje y el habla. Estos sistemas se caracterizan por el apoyo en el canal visual para acceder a la información o recurren al apoyo físico. Se apoyan en su propio cuerpo para configurar el mensaje.

Los sistemas **con ayuda externa**, requieren de instrumentos, a veces complicados y costosos, que conducen problemas de espacio y mantenimiento. Estos últimos, se orientan principalmente a mejorar la producción del habla, por eso se recurre a la ayuda de sistemas ortográficos, pictográficos e informáticos, que suplan las dificultades expresivo-articulatorias del sujeto. Entre sus características se destacan

algunas como: están basados en elementos muy representativos, en dibujos lineales (pictogramas), combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios, también se basan en la ortografía tradicional, se apoyan en aparatos de amplificación sonora de alta tecnología (Implante Coclear) y en software educativos para facilitar la comunicación.

La CA presenta **ventajas y desventajas**. Entre las *ventajas* más significativas están: contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y a mejorar el lenguaje oral, son reguladores de la conducta global del sujeto, mejoran las relaciones interpersonales y la competencia social del usuario, reducen la ansiedad, contribuyen a simplificar las estructuras morfosintácticas para favorecer la comprensión, favorecen la interacción comunicativa y permiten la formación de conceptos.

También pueden señalarse algunas *desventajas* como: Se reduce el círculo de interlocutores según el SCA empleado (es menos abierta), existen dificultades en el equilibrio entre el emisor y el receptor, la mayoría de los SCA son muy lentos y requieren de mayor amplitud de memoria y espacio y el modo de comunicación utilizado no es oral, el que preferiblemente se ha utilizado con respecto a otra forma de comunicación.

Los SCA en las personas con discapacidad parten de la concepción de estas personas desde la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, según la Organización Mundial, la que enfatiza desde una perspectiva optimista en lo que pueden hacer estas personas a partir de la ayuda de los otros. Desde esta perspectiva se plantea la discapacidad como un proceso interactivo. Se analiza el funcionamiento del individuo en un dominio específico, como una relación compleja de interacción entre la condición de salud y los factores contextuales (ambiental y personal). Existe una interacción dinámica entre estos elementos que tienen el potencial de modificar uno o más de estos; se dan en una relación recíproca que funcionan dos direcciones: la presencia de la discapacidad puede incluso modificar a la propia condición de salud.

En este sentido, es razonable considerar que un entorno educativo favorable que potencie la interacción de los factores ambientales para la participación, donde la condición de salud no constituye una limitante para desarrollar otras formas como la CA.

La discapacidad se ha concebido desde un modelo médico y social. El primero la considera como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad que requiere de cuidado y tratamiento individual por profesionales, dirigido a conseguir la cura y la adaptación de la persona y cambio de conducta de acuerdo con la enfermedad.

El segundo modelo, considera la discapacidad como un problema de origen social, centrado en la completa integración de la persona a la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones creadas por el contexto, por tanto requiere de una actuación social y una responsabilidad colectiva. De ahí se enfatiza en que la discapacidad se considera como “la relación del individuo con su entorno social”

Estas ideas permiten fundamentar desde la plataforma teórica del enfoque histórico-cultural, la comprensión acerca de las influencias educativas del entorno, con la creación de nuevas situaciones sociales del desarrollo a partir de la categoría vivencia, la que permite reconstruir la historia y la cultura de estas personas.

Desde el referido enfoque, se profundiza en la importancia de la comunicación para la formación de la personalidad. Sus sustentos tienen gran valor para establecer las relaciones interpersonales y acceder a la cultura independientemente de su condición social del desarrollo. Con un fundamento dialéctico-materialista profundiza en el desarrollo de las funciones psíquicas superiores, en contraposición con las posiciones biologicistas, por el hecho de que la cultura se da como un proceso independiente de la historia real de la sociedad.

La atención educativa a las personas con discapacidad, que son usuarios de la comunicación aumentativa, se fundamenta en la plataforma teórica del enfoque histórico-cultural.

Para satisfacer las demandas educativas de las personas con discapacidad que tienen severos problemas para comunicarse y no utilizan las vías convencionales de comunicación se favorecen con los SCA, para su desarrollo personal y social matizado por las categorías, leyes y principios del enfoque histórico-cultural que guían la atención educativa de estas personas que requieren de ayuda y recursos para responder a su demanda educativa.

En este trabajo se le da un alto valor a los SCA en las personas que presentan diferentes discapacidades (condición de salud), que tienen una incidencia significativa en la comunicación. Al valorar sus ventajas en el desarrollo personal y social de estas personas constituyen pautas importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje con las adaptaciones curriculares pertinentes que se realizan para el desarrollo de habilidades personales en estas personas como resultado de todos los factores implicados en ellas.

No se puede olvidar que cuando el niño nace, solo es portador de una serie de reflejos incondicionados, regulados por los centros nerviosos cerebroespinales y subcorticales; y que la corteza de los grandes hemisferios aún no se ha formado por completo; pero lejos de significar una debilidad, esto se constituye en una fortaleza, por cuanto le ofrece posibilidades ilimitadas para asimilar nuevas experiencias. Una condición indispensable para que madure el cerebro y se activen millones de circuitos neuronales, es la estimulación que proviene del exterior. Con la estimulación desde los primeros momentos de la vida, es posible ejercer una acción determinante sobre el desarrollo del ser humano, entre otras razones, debido a que las estructuras biofisiológicas y psicológicas, se encuentran en pleno proceso de formación y maduración. El cerebro, para apropiarse de la experiencia social, establece conexiones entre las células cerebrales y como resultado se desarrolla su capacidad para responder a diferentes exigencias, estímulos y entornos. Sin embargo, a pesar de la extraordinaria cantidad de neuronas que se posee al nacimiento, y las posibilidades incalculables de realizar sinapsis, la experiencia científica ha

demostrado que la no estimulación apropiada, o la falta de estimulación, no solo impide la proliferación de las células nerviosas, sino que hace que su número decrezca progresivamente, a pesar de las condiciones favorables que tiene la corteza cerebral. Por tanto, no basta con poseer desde el nacimiento un cerebro humano considerando que se puedan alcanzar determinados desarrollo de manera espontánea. Las experiencias adecuadas tienen un impacto decisivo en la arquitectura del cerebro, y la manera en que estas conexiones se establecen, deja huellas definitivas en la psiquis humana, causando su carencia, daños irreversibles en el niño y su vida futura. Por el contrario, una estimulación adecuada, actuará favoreciendo condiciones positivas para el desarrollo. Con lo anteriormente planteado se adopta una posición histórico-cultural del desarrollo, para la cual, la educación desempeña un papel esencial, al constituirse en un proceso mediante el cual, el niño se apropia activamente de la cultura de su época y contexto socio cultural específico, y en ese proceso de apropiación se produce su desarrollo psíquico. Lo anterior implica otorgar al factor biológico el lugar que le corresponde: ser portador de un cerebro sano, no es suficiente, si a esto no se une una estimulación educativa apropiada, capaz de ser incorporada a partir de la enorme plasticidad que le es inherente a este órgano. De acuerdo con la ley genética fundamental del desarrollo planteada por Vigotsky, cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena en dos planos: primero como algo social y después como algo psicológico; primero como una categoría intersíquica, y después, como una categoría intrapsíquica. Esto tiene un alto significado para la concreción de la educabilidad del niño, porque implica que, de la actividad y la comunicación que se establezca entre éste y los que le rodean, dependerá en gran medida su desarrollo. La naturaleza social y cultural del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, depende de la cooperación con los adultos y de la educación.

Creo que aquí puedo hablar de la importancia del implante colear en edades tempranas, lo que favorece el desarrollo de la comunicación y consigo la interacción social. Solo un poco porque del IC se habla al referirse a las particularidades de las estrategia de CA en el epígrafe 1.3.

1.2 La comunicación aumentativa como vía para la atención educativa a niños sordociegos de la primera infancia.

A consideración de Chkout T.” la sordoceguera es una discapacidad que puede presentar un ser humano, al poseer de manera combinada una pérdida significativa o total de la audición y la visión, que genera una forma peculiar de comunicación con el mundo que le rodea, mediante la utilización de los analizadores conservados, con énfasis en el tacto, lo que le permite a partir de sus potencialidades, el aprendizaje, el lenguaje, la orientación y la movilidad, así como su integración (Chkout T. 2007:29)

Las causas que hacen que una persona sea sordociega son diversas y pueden producirse en diferentes momentos de la vida, entre estas pueden mencionarse: prematuridad, influencia de diversos factores genéticos, Meningitis, Toxoplasmosis, Rubéola, Diabetes congénita, Abuso de drogas, enfermedades de transmisión sexual (SIDA, sífilis), Alcoholismo durante el período de gestación, Asfixia, Traumas o accidentes craneales, síndromes (Usher, Charge) entre otras.

Así mismo se clasifica la sordoceguera: dependiendo del grado de compromiso sensorial puede ser total o parcial, por el momento de aparición esta puede ser: congénita, a temprana edad, sordera congénita con ceguera adquirida, ceguera congénita con sordera adquirida y sordoceguera tardía.

Por nivel de funcionamiento pueden ser: sordociego de bajo nivel de funcionamiento, sordociego de nivel de funcionamiento medio, sordociego de alto nivel de funcionamiento.

Es extremadamente importante el conocimiento de las particularidades que pueden presentar los niños sordociegos en el proceso de desarrollo de la comunicación, pues teniendo el intelecto normal, pero sin una comunicación organizada y apoyada por las personas que le rodean, ellos pueden llegar al aislamiento total y el desarrollo de su psiquis quedará afectada.

Por el desarrollo de la comunicación se clasifican en presimbólicos y simbólicos. Estos se diferencian a partir de las posibilidades que tienen para lograr la conexión con el medio que le rodea y las potencialidades para el desarrollo del lenguaje en su función comunicativa. Presimbólicos son aquellos que no interactúan con el medio, no tienen forma convencional de comunicación (gritos, llantos, conductas diferentes), no tienen formas de representar el mundo, emergente (aceptan al “otro” y responden a códigos), impresionan conductas similares a la de los niños autistas, manifiestan hiperactividad o hipoactividad, agresivas o autoagresivas y presentan dificultades en el desarrollo de las conductas alimentarias, se cansan con facilidad. Estos niños pueden llegar a una imitación elemental, frecuentemente viven sin saber lo que sucede a su alrededor y no establecen diferencias entre sí mismo y los demás objetos que le rodean.

Simbólicos son considerados aquellos que usan alguna forma de comunicación, representan el mundo y son capaces de generar o imitar gestos o señas sencillas para comunicarse, con ayuda pueden desarrollar la comunicación elemental y expresar sus deseos y necesidades. Aceptan fácilmente el contacto con el otro.

Todos sabemos que la comunicación es la clave del acceso al aprendizaje, al conocimiento y a la relación con los demás. Dentro de los programas de atención para personas sordociegas una parte muy importante es el desarrollo y la potenciación de las habilidades comunicativas, a través de la enseñanza del adecuado sistema de comunicación en cada caso y de otros cuando sea posible.

La comunicación interpersonal es el reto más difícil para estas personas, las que necesitan expresar sus necesidades y deseos, comprender lo que sucede a su alrededor, pero tienen grandes dificultades para acceder al lenguaje oral y al gestual, tanto a nivel expresivo como receptivo.

En este proceso es muy importante la comunicación entre la persona con sordoceguera y el especialista en movilidad, incluso se solicita el servicio de un intérprete-guía para su atención educativa. Se trata de un manejo individualizado que tenga en consideración varios aspectos como: la fortaleza física, el sentido del tacto como principal fuente de estímulos, la intervención logopédica, la orientación y la movilidad, el establecimiento de la comunicación mediante diferentes ayudas.

Para las personas con sordoceguera adquirida que se comunican con sistemas alfabéticos, no es suficiente el uso de un alfabeto manual para conseguir una comunicación rápida y satisfactoria a la hora de traducir y seguir el ritmo normal de los mensajes orales: hay que incorporar signos o símbolos para conseguir más velocidad.

En caso de sordoceguera congénita, nuestra labor sería la de construir el mundo en la mente del niño. En el caso de la sordoceguera adquirida tenemos, en cambio, la labor de reconstruir un mundo ya conocido.

Estos niños con frecuencia manifiestan conductas de inseguridad, pasividad, agresión al otro y autoagresión. Esto es debido a las limitaciones que poseen de acceso al medio en que se desarrollan; pero también poseen grandes potencialidades en el uso del tacto, el gusto y el olfato; a través de las cuales se favorece su interacción social.

- Pueden aprender a utilizar el tacto como vía esencial para el desarrollo intelectual, las relaciones sociales y como instrumento para mantener el contacto con la realidad.

Sus primeras comunicaciones recibidas por medio de la piel tienen gran influencia en el aprendizaje de la lectoescritura, lo ayuda a manifestar las expresiones de cariño, amistad, tristeza y otras, así como a conocer su cuerpo y el del otro; permite también la estimulación de los procesos de razonamiento y memoria.

- Pueden aprender a utilizar el olfato como vía de comunicación para establecer relaciones humanas, lo que facilita la orientación espacial (el olor de la cocina, del cuarto, de la calle) y la prevención del peligro (olor de gas, de humo, de sustancias químicas). A través del olfato puede reconocer a personas cercanas, quizás por su perfume, su olor característico del cuerpo. La estimulación del olfato contribuye al desarrollo de la memoria y los procesos de razonamiento (puede recordar objetos, hechos, frutas)
- Pueden aprender a utilizar el gusto, lo que contribuye al desarrollo de sus emociones (los sabores de las comidas, la prevención de los peligros), a la comprensión de los conceptos abstractos (caliente, frío, suave, duro, amargo), esto favorece la aparición de las preferencias de sus gustos, ayudan a escoger y desarrollar las elementales habilidades domésticas.
- Pueden llegar a elaborar un modelo de comportamiento, adaptarse adecuadamente al entorno y desarrollar así su comunicación con el medio.
- Pueden relacionarse con el mundo que le rodea por diferentes sentidos, lo que les permite percibir aproximadamente el 13% de la información sobre la realidad, esto los diferencia en gran medida de los niños sordos y ciegos que tienen la oportunidad de utilizar la visión o audición para comunicarse.
- Debido a la inexistencia de un lenguaje natural pueden utilizar como fuente de apoyo diferentes sistemas aumentativos de la comunicación.

Puede darse el caso de que estas potencialidades no lleguen a su máxima expresión. Es por ello que para responder a las demandas educativas de los niños sordociegos es importante tener en cuenta la calidad de la información sensorial recibida por el niño, que por lo general es limitada o distorsionada debido a los daños en los analizadores visual y auditivo.

Se hace necesario definir en el desarrollo de esta investigación el concepto de **Primera Infancia** asumiendo lo expresado por la doctora en ciencias Isabel Ríos, quien plantea que: los niños y las niñas de la primera infancia son seres biológicos en intenso crecimiento; seres sociales y culturales por su origen que devienen

individuales a partir de la apropiación activa de las experiencias aportadas por su medio específico; seres afectivos y dependientes, con capacidad para transitar al autovalidismo; con extraordinario potencial de desarrollo; y portadores de derechos para el alcance de una vida plena. Propuesta científica de la Dr.C Isabel Ríos Leonar (2006: 63)

Esta primera etapa de la vida, es reconocida, ya sin discusión, por los aportes que brinda a todo el desarrollo posterior del ser humano, denominada también por la literatura científica como edad preescolar. En la esfera de la educación dicha influencia es remarcada al denominar todas las acciones que se realizan con el niño de cero a seis años como educación preescolar.

Se asume el criterio de Isabel Ríos al expresar que los tres primeros años, en el que el crecimiento y el desarrollo del niño, sus adquisiciones, tienen un ritmo muy intenso; y no solo las funciones y procesos psíquicos aislados, sino la combinación de los mismos es particular, en que su sistema nervioso y organismo en general, es más frágil, en que las relaciones con los demás son limitadas; podrá ser denominada infancia temprana; y de tres a seis años en que comienza a percibirse una diferenciación sustancial, otro tipo de relación con los coetáneos y otras actividades que le proporcionan satisfacción y desarrollo (entre las que se destaca el juego), como infancia preescolar.

No se puede olvidar que cuando el niño nace, solo es portador de una serie de reflejos incondicionados, regulados por los centros nerviosos cerebroespinales y subcorticales; y que la corteza de los grandes hemisferios aún no se ha formado por completo; pero lejos de significar una debilidad, esto se constituye en una fortaleza, por cuanto le ofrece posibilidades ilimitadas para asimilar nuevas experiencias. Una condición indispensable para que madure el cerebro y se activen millones de circuitos neuronales, es la estimulación que proviene del exterior.

Con la estimulación desde los primeros momentos de la vida, es posible ejercer una acción determinante sobre el desarrollo del ser humano, entre otras razones, debido a que las estructuras biofisiológicas y psicológicas, se encuentran en pleno proceso de formación y maduración. El cerebro, para apropiarse de la experiencia social, establece conexiones entre las células cerebrales y como resultado se desarrolla su capacidad para responder a diferentes exigencias, estímulos y entornos. Sin embargo, a pesar de la extraordinaria cantidad de neuronas que se posee al nacimiento, y las posibilidades incalculables de realizar sinapsis, la experiencia científica ha demostrado que la no estimulación apropiada, o la falta de estimulación, no solo impide la proliferación de las células nerviosas, sino que hace que su número decrezca progresivamente, a pesar de las condiciones favorables que tiene la corteza cerebral.

Por tanto, no basta con poseer desde el nacimiento un cerebro humano considerando que se puedan alcanzar determinados desarrollo de manera espontánea. Las experiencias adecuadas tienen un impacto decisivo en la arquitectura del cerebro, y la manera en que estas conexiones se establecen, deja huellas definitivas en la psiquis humana, causando su carencia, daños irreversibles en el niño y su vida futura. Por el contrario, una estimulación adecuada, actuará favoreciendo condiciones positivas para el desarrollo.

Con lo anteriormente planteado se adopta una posición histórico-cultural del desarrollo, para la cual, la educación desempeña un papel esencial, al constituirse en un proceso mediante el cual, el niño se apropia activamente de la cultura de su época y contexto socio cultural específico, y en ese proceso de apropiación se produce su desarrollo psíquico.

Lo anterior implica otorgar al factor biológico el lugar que le corresponde: ser portador de un cerebro sano, no es suficiente, si a esto no se une una estimulación educativa apropiada, capaz de ser incorporada a partir de la enorme plasticidad que le es inherente a este órgano. De acuerdo con la ley genética fundamental del desarrollo planteada por Vigotsky, cualquier función en el desarrollo cultural del niño

aparece en escena en dos planos: primero como algo social y después como algo psicológico; primero como una categoría intersíquica, y después, como una categoría intrapsíquica. Esto tiene un alto significado para la concreción de la educabilidad del niño, porque implica que, de la actividad y la comunicación que se establezca entre éste y los que le rodean, dependerá en gran medida su desarrollo. La naturaleza social y cultural del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, depende de la cooperación con los adultos y de la educación.

1.3 Particularidades de las estrategias de comunicación aumentativa en niños sordociegos de la primera infancia.

La comunicación aumentativa se caracteriza por el apoyo en el canal visual para acceder a la información o recurren al apoyo físico, en el caso de las personas con sordoceguera, no necesitan ningún instrumento físico adicional para comunicarse, se emplean gestos de uso común y códigos gestuales no lingüísticos, sistemas de signos gestuales (lengua de señas o de signos). Se apoyan en su propio cuerpo para configurar el mensaje.

Partiendo de la clasificación que se le da a los SCA (con ayuda y sin ayuda externa) a continuación se presentan dichos sistemas que son utilizados sin ayuda externa en niños sordociegos de la primera infancia.

- a- Sistemas alfabéticos; exige de los usuarios e interlocutores el dominio del sistema de lectura y escritura en tinta o en braille. Cuando las personas con sordoceguera tienen resto visual pueden utilizar el alfabeto manual empleado por la comunidad sorda, se debe respetar su campo visual y la distancia que le permita verlos según su agudeza. También se utiliza con adaptación táctil y se conoce con el nombre de alfabeto dactilológico en palma. En este caso, para cada letra hay dos dibujos, el primero corresponde al signo manual de la letra y el segundo, a su colocación sobre la palma de la mano para la versión táctil.

El interlocutor se sitúa en frente o al lado de esta persona, coge suavemente una de sus manos con su mano izquierda y sobre la palma de la mano, que puede estar en posición vertical u horizontal, coloca cada una de las letras de la palabra.

Escritura de mayúsculas en la palma de la mano; este resulta el método de más fácil acceso para comunicarse con una persona con sordoceguera que conozca la escritura sobre papel. Se escriben las letras de cada palabra en mayúscula sobre la palma de la mano, se sigue el mismo trazado que se hace al escribir.

Sistema Braille; es el sistema táctil de lectoescritura más utilizado por las personas con discapacidad visual o invidentes como también se les llama. Con él pueden comunicarse sin restricciones. Se utilizan estrategias especiales, entre las que se encuentran las siguientes:

* Tablilla de comunicación: Es una pieza rectangular (12x8 cm) que contiene cuatro filas con las letras del alfabeto y los diez números, en braille y en escritura alfabética en mayúsculas. Resulta muy manejable y fácil de transportar. Se utiliza para la comunicación de mensajes cortos entre personas que saben leer y escribir.

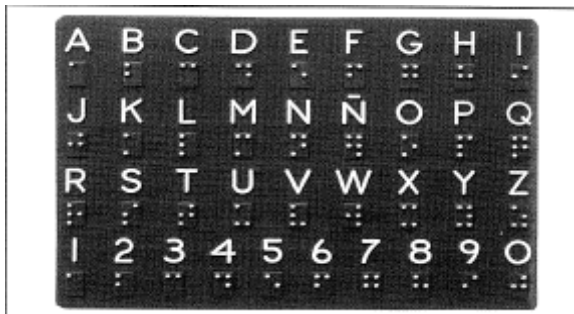
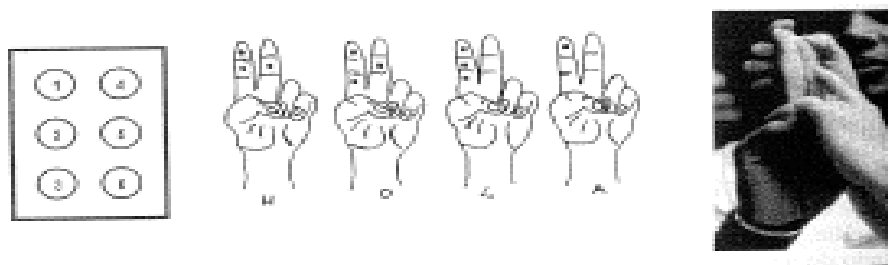


Fig. N Tablilla de comunicación

El método digital Braille; se traslada este sistema a los dedos de la mano. Se cierran los dedos de la mano en forma de puño, estirándose solamente el índice y el medio, de forma que queda la letra “V” En el dedo índice de, de arriba hacia abajo, cada falange es un punto de la primera columna del signo generador braille(puntos 1, 2 y 3). En el dedo medio cada falange, de arriba abajo, contiene los puntos 4, 5 y 6

respectivamente. El interlocutor toca una por una las falanges correspondientes a los puntos de cada letra en braille.



b- Sistemas no alfabéticos; estos sistemas no se basan en códigos alfabéticos sino en el lenguaje oral, en la vibración táctil (método Tadoma), la lengua de signos o de señas y el sistema bimodal. A continuación se precisan las particularidades de cada uno en esta población.

- * El lenguaje oral; se emplea en aquellos sujetos que no presentan problemas graves de audición que los limiten a la articulación de fonemas. Su medio de transmisión es el habla. Su aprendizaje y uso exigen de un buen nivel de atención y agudeza visual.

- * El método Tadoma; consiste en la lectura de los labios a través de las manos. Se colocan las manos de la persona con sordoceguera sobre los labios, la mejilla y cuello del interlocutor, aprende a captar la vibración de cada sonido, a reconocerlo y a reproducirlo.

- * La lengua de signos o señas; constituye la lengua propia de las personas sordas prelocutivas y junto a la dactilología es el sistema más utilizado por los sujetos con sordoceguera y el que han aprendido desde los primeros años de vida. Siempre que se conserve el resto visual, podrá ser utilizado sin apoyo físico. Hay que considerar la amplitud del campo visual, la distancia de presentación y las condiciones de la iluminación para la comunicación. Ante la ausencia de restos visuales, la lengua de señas se utiliza con apoyo físico. Se ponen en contacto las manos de los interlocutores, se facilita las referencias necesarias de los movimientos de cada gesto. De esta forma, frente a frente, de pie o sentados se entabla una conversación.

✱ El sistema bimodal; permite a las personas con sordoceguera aprender el sistema oral usando signos manuales en lugar de palabras articuladas.

Se considera también un SCA la utilización del *Implante Coclear* (IC) como una de las estrategias con ayuda externa de carácter tecnológico, siendo este un dispositivo electrónico capaz de recoger señales sonoras, transformarlas a señales eléctricas y transmitir las al nervio auditivo en la cóclea, mediante un complejo mecanismo de amplificación, compresión, filtración y codificación.

Esta novedosa tecnología permite adquirir la información auditiva y mejorar la comunicación con personas, que debido a una pérdida auditiva profunda no logran percibir bien y comprender el lenguaje hablado con los audífonos convencionales (amplificadores de sonido de uso colectivo o individual). Los IC son indicados a las personas con sordera profunda o severa.

Los implantes cocleares están conformados por dos partes: externa (Micrófono, transmisor, procesador del habla, cables de conexión y baterías) e interna (receptor interno y electrodos)

El mecanismo de funcionamiento del IC es el siguiente: el micrófono recoge los sonidos y los envía a través de un cable al procesador del habla donde se codifican las respuestas y luego se envían a través del cable al transmisor externo, el cual transmite este código en forma de señales FM (Frecuencia Modulada) a través de la piel hacia los componentes internos. El implante es colocado debajo de la piel y se conecta a través del cable a la cóclea, donde los electrodos estimulan las fibras del nervio y el sonido de esta manera se transmite al cerebro.

Los niños sordociegos con más frecuencia tienen contraindicaciones para colocársele el IC, debido a las agravantes de salud y los síndromes que los acompañan frecuentemente.

Uno de los mayores problemas para la utilización de la CA en estos usuarios es la lentitud en la transmisión de mensajes, sobre todo cuando se utilizan métodos alfabéticos. La lengua de señas le permite acceder mejor a la información y se comunican con mayor facilidad. La elección del sistema se realizará en función de

sus demandas educativas, lo más importante es la búsqueda de recursos y estrategias para que se comuniquen, no solo por constituir un derecho para su educación e inserción social, sino que tienen potencialidades para desarrollarse a pesar de esa condición de discapacidad sensorial.

A partir de que los niños con sordoceguera tienen dificultades en la comunicación y en la orientación y la movilidad como base para el acceso al aprendizaje y su desarrollo personal que implican particularidades en la atención de este proceso y asumiendo el criterio de dos autores: Torres Monreal, Santiago y María Lucía, tienen esta distinción:

Se incluyen en las de tipo *anticipatorio*: calendario de actividades y objetos de referencia; en las de tipo *electiva*: la comunicación intencional; y en las de tipo *representativa*: el lenguaje gestual (Lengua de Señas Táctil), Tablero de comunicación (a relieve), Comunicación como proceso multimodal y los Sistemas alfabéticos y no alfabéticos.

2. Presentación de la propuesta. Estrategias de comunicación aumentativa para la educación de los niños con sordoceguera de la primera infancia.

La estrategia está dirigida a facilitar situaciones controladas de comunicación que ayudan a la anticipación de lo que va a ocurrir y controlan sus propias acciones sobre el entorno. Torres S. 2001

Esta propuesta se sustenta en fundamentos filosóficos, pedagógicos, sociológicos, psicológicos y didácticos.

Las estrategias de comunicación aumentativa desde lo **filosófico** tienen en cuenta el método dialéctico-materialista, que le permite el estudio y análisis de los objetos y fenómenos de la realidad de forma objetiva, integrada y multilateral, favoreciendo la comprensión de los mismos. Se asume la concepción de desarrollo como categoría, la que establece un desenvolvimiento dinámico en el aprendizaje que va de formas inferiores a superiores, puesto de manifiesto en las diferentes estrategias, diseñadas de contenidos más generales a específicos, relacionados con la comunicación.

Desde el punto de vista de lo **sociológico**, se tiene en cuenta la socialización como proceso de desarrollo del individuo. Esto contribuye de una manera afectiva e integrada al aprendizaje, a la formación y desarrollo de los conocimientos donde las vivencias y los otros aportan al aprendizaje, lo que permite aunar los esfuerzos, buscar los recursos según el caso, para cumplir de manera exitosa con la atención a los niños con diagnóstico de sordoceguera.

En lo **psicológicos**, se tiene como referencia los postulados de la escuela histórico-cultural y se parte de la ley de la mediación de lo psíquico, al considerar que todo el desarrollo psicológico del ser humano es producto de la mediación que ejerce las personas, los objetos, los instrumentos, los signos y los significados en el sujeto en desarrollo.

Desde lo **pedagógico** se asume la unidad dialéctica que establece entre la educación y la instrucción con una visión optimista, humanista de la atención a las necesidades educativas especiales, se toman los postulados de Vigostki, donde la comunicación, las vivencias y el papel de los otros como mediadores del desarrollo.

Desde lo **didáctico** cumple con las estrategias de comunicación aumentativa dependiendo del diagnóstico, principalmente con el grado de su afectación comunicativa y con los logros del desarrollo por edades. Ofrece tratamiento mediante las acciones que se presentan y da salida a las potencialidades que brinda el uso de estas estrategias. Se sustenta el contenido seleccionado para preparar las diferentes estrategias de comunicación aumentativa para el desarrollo de la esta.

En la atención educativa a las personas usuarias de los SCA, se emplean diversas estrategias como las planteadas por Torres Monreal y otros , quienes hacen énfasis en las habilidades de los usuarios de la CA, los que tienen grandes limitaciones para relacionarse con el entorno y desconocen las estrategias para la comunicación, además de que habitualmente reciben menos atención. Para su introducción es necesario facilitar situaciones controlables que ayuden a la anticipación de lo que va

a ocurrir, al control de sus propias acciones sobre el entorno, para lo cual proponen tres estrategias de comunicación: anticipación, elección y representación, por ejemplo:

- El calendario de actividades; dirigido a la rutina diaria, en cualquier momento del día, lo que favorece la estructuración espacio-temporal tanto en el hogar como en el centro educativo, el niño aprende a anticipar lo que va a suceder y a controlar sus acciones.
- El uso de objetos de referencia; le permite la interacción con el medio para comunicar necesidades y sentimientos mediante mecanismos que lo ayuden a hacerlo. Estos objetos ofrecen un punto de partida igual que si se utilizaran palabras articuladas y escritas. Esta estrategia tiene múltiples ventajas, entre ellas: anticipan lo que va a ocurrir, reducen la ansiedad e inseguridad, facilitan la expresión de necesidades y la autonomía personal, otras.
- La comunicación intencional; permite elegir el programa de comunicación que se va a utilizar en situaciones comunicativas reales como: conseguir varios objetos preferidos en correspondencia con la situación en que van a ser presentados, distinguir los de alto interés y los que no le interese al usuario; preguntar al usuario lo que quiere y esperar una opción como respuesta, con el fin de proporcionarles claves visuales y verbales, cuando el alumno toque el recipiente que contenga el objeto deseado, se le dará inmediatamente su duplicado para que vivencie el valor de representación.
- Introducción del lenguaje gestual; tiene como propósito que todas las actividades comunicativas se acompañen de gestos básicos relativos a actividades cotidianas (dormir, comer, aseo, juego) realizadas por el adulto a la vez que emplea el lenguaje oral. En el caso que existan problemas visuales se utiliza el apoyo físico, el aprendizaje del gesto mediante el movimiento refuerza la atención visual. Habla signada.
- Creación de tableros de comunicación; constituye una opción cuando una persona es capaz de reconocer representaciones de la realidad (objetos, personas, acciones...) a través de dibujos o símbolos (pictogramas, lenguaje escrito, colores). Por ejemplo, las claves para la estructuración del Bliss.

Por otra parte, en relación con este aspecto, Díaz, Ma. Lucía, ilustra otras estrategias, las que tienen bastante similitud con las mencionadas anteriormente, ellas son:

- La comunicación como proceso multimodal; la que enfatiza en aprovechar cualquier modo de expresión del niño, la que incluye por ejemplo: una sonrisa, un llanto, otros. Este debe percibir que es merecedor de ser atendido.
- Dar información por adelantado; se ofrecen al alumno claves necesarias que le ayuden a saber dónde está, dónde va a ir, qué actividad es la siguiente, qué adulto de referencia va a aparecer en la próxima escena. Esas vivencias lo ayudan a comprender su presente y que se disponga a aprender a comunicarse.
- Dar oportunidades de comunicación; la prisa por conseguir una comunicación fluida y eficaz, en ocasiones frena la producción comunicativa espontánea, por eso no se trata solo de conocer la CA, sino de ser pacientes, de adecuarse al estilo comunicativo del interlocutor, a su ritmo, tiempo de emisión de respuesta, se trata de lograr funcionalidad para que inicie y finalice su mensaje.

2.1 Operacionalización de la variable. Dimensiones e indicadores.

Se procede a la determinación de la variable, sus dimensiones e indicadores. Ello permitió organizar el diagnóstico inicial con vistas a corroborar la situación problemática y determinar la propuesta que podría ser utilizada para su solución.

El análisis de los referentes teóricos abordados permite una aproximación a la definición operativa de la variable y operacionalizar sus dimensiones e indicadores.

La comunicación aumentativa en la educación de niños con sordoceguera de la primera infancia: se refiere al empleo de estrategias que facilitan la comunicación en la educación de niños con sordoceguera, que presentan dificultades graves para el habla y exigen de un aprendizaje formal para facilitar su crecimiento como seres sociales y culturales.

Por tanto se identifican como dimensiones e indicadores los siguientes:

Dimensiones	Indicadores
Interacción social	a- Aceptación de otros. b- Facilidad de imitación. c- Atiende al sonido detectado. d- Localiza la fuente sonora.
Estrategias de comunicación utilizadas	a- Muestra iniciativas para comenzar acciones. b- Anticipación de acciones. c- Representación de acciones. d- Elección de acciones.

En el diagnóstico del problema que se investiga se precisan las siguientes regularidades, según las dimensiones e indicadores que caracterizan la comunicación aumentativa en los niños autistas.

- En el análisis documental (anexo 1), al ser analizados los documentos metodológicos dirigidos al proceso de atención educativa al niño con diagnóstico de sordoceguera (expedientes logopédicos, psicopedagógicos y libretas de orientación a padres y a maestros por parte de los especialistas) se pudo constatar que no es suficiente el tratamiento que se le da a los sistemas de comunicación aumentativa, tanto con ayuda como sin ayuda externa. En ocasiones se refieren a algunos de ellos y no lo reconocen como tales. Por eso se valora de BAJO.
- En las actividades observadas (anexo 2) se privilegia el empleo del habla signada y la lectura global, así como las claves visuales para la orientación de los procesos de la vida cotidiana. Esto coincide con la carencia de conocimientos en cuanto a la diversidad de estrategias de comunicación aumentativa. La valoración de las observaciones se evalúa de MEDIO.
- Al comprobar la preparación de los maestro y especialistas en el empleo de los SCA (anexo 3) se valora de MEDIO, se evidencian carencias en el

conocimiento del empleo de estos sistemas, dirigidos a desarrollar la capacidad de comunicación en personas con diagnóstico de sordoceguera y existen dificultades en cuanto a su clasificación.

- Guía de observación a diferentes actividades (anexo 4)
- En la entrevista a la familia (anexo 5), se constatan resultados MEDIOS, sus respuestas en ocasiones coinciden con las dificultades que presentan los maestros y especialistas de la escuela, son estos quienes tienen la responsabilidad de orientar a la familia en cuanto al uso y metodología de estas Estrategias de Comunicación para potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas en los niños con sordoceguera.

Al realizar una valoración general de los instrumentos que fueron aplicados durante esta investigación se evidencian las dificultades en el empleo de estos sistemas que exigen de una sistematización teórica y metodológica para favorecer el desarrollo de las personas con diagnóstico de sordoceguera.

2.2 Análisis del proceso y los resultados del diagnóstico inicial.

Principales regularidades del diagnóstico:

Interacción social

- ✓ Acepta a las personas más cercanas a ella (familia, maestros y especialistas)
- ✓ La niña imita algunos sonidos
- ✓ La niña imita algunos sonidos
- ✓ La niña imita algunos sonidos
- ✓ La niña imita algunos sonidos

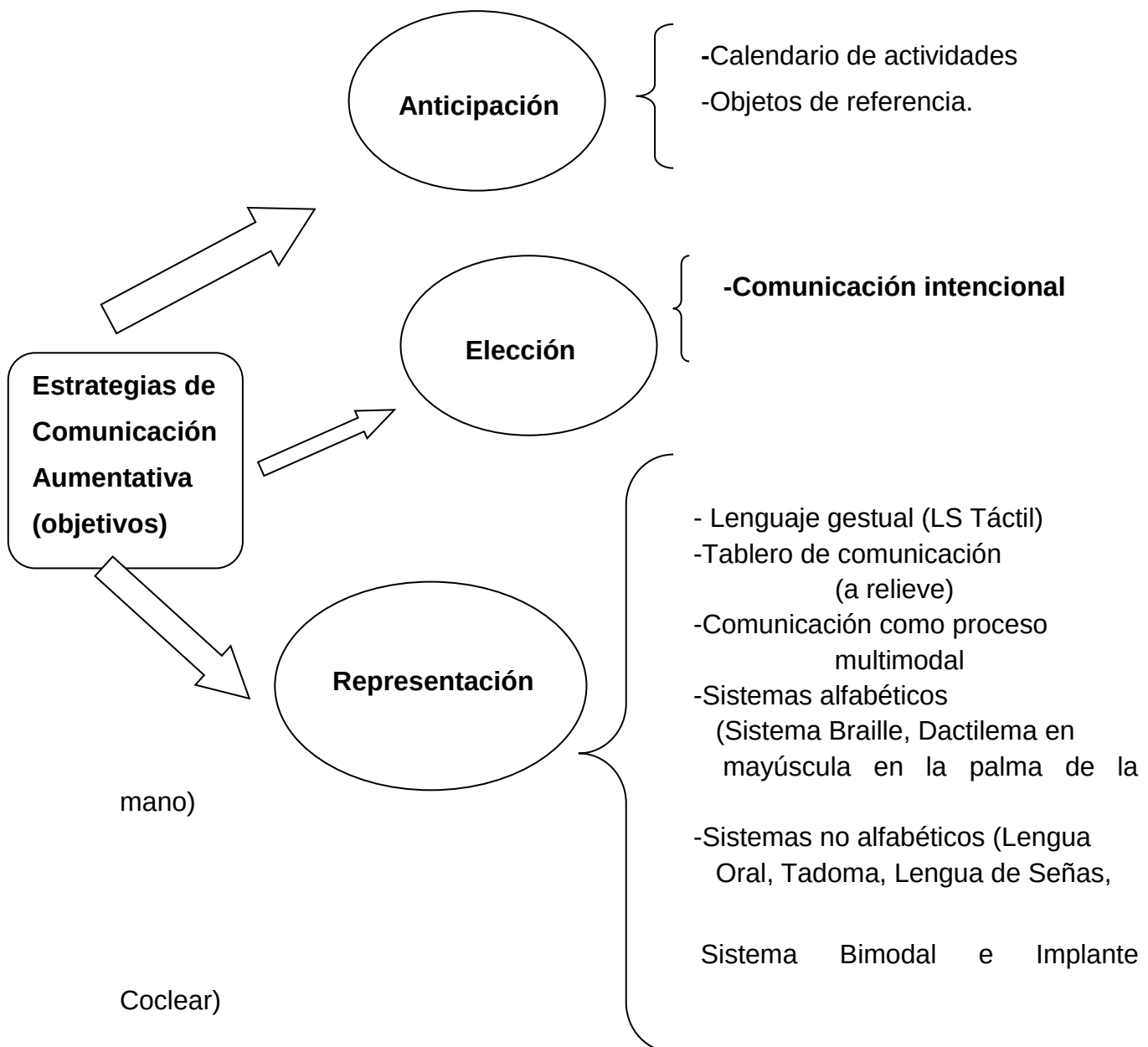
Estrategias de comunicación utilizadas

- ✓ Muestra iniciativa para comenzar acciones en diferentes situaciones comunicativas.
- ✓ Muestra iniciativa para comenzar acciones en diferentes situaciones comunicativas.
- ✓ Muestra iniciativa para comenzar acciones en diferentes situaciones comunicativas.

- ✓ Usa la lengua de señas táctil como estrategia representativa
- ✓ La niña se encuentra en la primera etapa de desarrollo de la percepción auditiva con el implante coclear.(detección-discriminación)

En las actividades docentes se utilizan algunos recursos vinculados a las estrategias de comunicación aumentativa se emplean mayormente el objeto de referencia, el calendario de actividades y la lengua de señas (táctil) desaprovechándose la utilización de otros sistemas de comunicación.

Esquema de la propuesta



CONCLUSIONES

- Los SCA para la educación de los niños con diagnóstico de sordoceguera tiene un valor incalculable en la formación de su personalidad porque facilitan la comunicación, la Orientación y la Movilidad, el acceso al aprendizaje y su inclusión educativa como expresión legítima del desarrollo al disfrute de una educación de calidad como el resto de los niños.
- La CA en los niños sordociegos tienen la particularidad de integrar los sistemas con ayuda y sin ayuda externa por la importancia de la mediación social-instrumental para interactuar con el mundo que lo rodea, así como la aceptación del interlocutor como base para la adquisición de vivencias y el desarrollo de un código simbólico que le facilite la comunicación con el empleo de diferentes estrategias.
- Los resultados del estudio realizado permitieron constatar las insuficiencias que se presentan en la práctica pedagógica para el empleo de la diversidad de SCA por su complejidad en una discapacidad donde se comprometen dos sistemas funcionales sensoriales, los que exigen de una elevada profesionalidad para la aplicación de las estrategias de CA.
- La propuesta de estrategias de CA en los niños con diagnóstico de sordoceguera tiene como propósito aumentar la capacidad de comunicación a partir de la creación de situaciones comunicativas favorables para ellos, como: Calendario de actividades, lengua de señas táctil, objetos de referencia, etc.

RECOMENDACIONES

- Continuar profundizando en el estudio de esta temática por la importancia que tiene el desarrollo de la comunicación, el aprendizaje y el desarrollo integral de la personalidad de las personas sordociegas.
- Sistematizar la propuesta de Estrategia de Comunicación Aumentativa en la práctica educativa.

Bibliografía

1. Álvarez, D, La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar. La sordoceguera, Una discapacidad singular, Madrid 2004
2. Alvarez, C. y otros. Evaluación, diagnóstico y prevención. Curso 5. Maestría en educación especial. Universidad Bolivariana de Venezuela. Centro internacional Miranda. 2010
3. Álvarez, C. Metodología a seguir para el estudio de caso como método cualitativo de investigación. 1998 (Folleto digital).
4. Almenares, D. Apoyo a los niños sordociegos con implante coclear. Manual a la familia.
5. Azcoaga, J. Del lenguaje al pensamiento verbal. Editorial Pueblo y Educación. 2003
6. Espejo, B. Comunicación Aumentativa en personas con sordoceguera. Sistemas Alternativos de Comunicación. Manual de Comunicación Alternativa: sistemas y estrategias. Ediciones. Aljibe, S.L (Málaga), España.
7. Benavides, Z. Lecturas de pedagogía preescolar. Editorial Pueblo y Educación. 2011
8. Betancourt, J. y otros. Fundamentos de psicología. Primera parte. Textos para estudiantes de las carreras Licenciatura en Educación Especial y logopedia. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 2012.
9. Betancourt, J. y otros. La comunicación educativa en la atención a niños con necesidades educativas especiales. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 2003.
10. Castellanos, R.M y Rodríguez, X. Actualidad en la educación de niños sordos. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2003.
11. Castro, P.L. y otros. La labor preventiva en el contexto familiar. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 2010.
12. Chávez, J.A. y otros. Acercamiento necesario a la pedagogía general. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 2005.

13. Chkout Tatiana. La evaluación y diagnóstico de niñas, niños y adolescentes sordociegos. Material de apoyo para los docentes. (MINED 2007)
14. Chkout Tatiana. A niños y adolescentes sordociegos. Editorial Pueblo y Educación. 2007.
15. Chkout Tatiana. Punto de partida. Lecturas para la familia. Dirección de Educación Especial, MINED, La Habana, 2008.
16. Chkout, T. y Morales, T. Los niños con implante coclear. Un acercamiento a la atención psicopedagógica. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 2008.
17. Colectivo de autores. Sublime profesión de amor. Educación Especial en Cuba. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 1996.
18. Cuevas, L.M. El proceso de evaluación desde una perspectiva funcional y ecológica dirigida a escolares con sordoceguera. Molinos Trade S.A. Ministerio de Educación, la Habana, 2012.
19. Díaz, M. L. Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Consejería de Educación y Cultura. Murcia, España. 2004.
20. Fernández, G. y Rodríguez, X.: Logopedia para las carreras de Logopedia y Educación Especial. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 2012.
21. Fernández, G. La atención logopédica en la edad infantil. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2008.
22. Fernández, I. y Vázquez, G. Recursos tecnológicos para el tratamiento logopédico. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2008.
23. González, Alicia y Rooms, Isis. Lecturas sobre la educación y el desarrollo sensorial. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2012.
24. Hernández, Caridad. Desarrollo de las concepciones educativas de las personas con discapacidad visual. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2011.
25. Holvoet, J. F. Helmstetter, E. Medical problems of students with special needs: A guide for educators. Boston: College-Hill Press. 1989.
26. Kaplún, M. Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre. Madrid, 1998.
27. Mesa, Paulina. Y otros. El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2006.

28. Ponce de León, M y Perera, M. Clínica audiológica. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2006.
29. Organización Mundial de Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, España. 2001, pág 22.
30. Pérez, G., García, G., Nocedo, I., García, M.: Metodología de la investigación educacional. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba. 1996.
31. Rodríguez Xiomara. Sistemas de Comunicación Aumentativa para personas con discapacidad. Material de apoyo a la docencia. UCP EJV. 2010
32. Rodríguez, X.: Sistemas de comunicación alternativo y/o aumentativo para personas con discapacidad. Revista Educación: La comunicación, siempre. N° 120. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba. Enero-abril, 2007.
33. Rodríguez, X. y Cobas, C.L. Los Sistemas de Comunicación Aumentativa en las personas con Necesidades Educativas Especiales. Curso 10. Conferencia científica del CELAE. La Habana, 2010.
34. Socorregut Garros y Silvio Ernesto. Regreso del mundo del silencio. Clínica Central Cira García Reyes. Febrero 2005-Enero2006. Licenciado en Enfermería .Miembro Titular de la SOCUENF.
35. Tamarit, J. y otros: "Qué son los sistemas de comunicación aumentativa" en Sistemas Alternativos de Comunicación. Editorial Trotta. Madrid, España. 1993.
36. Torres, Santiago. Sistemas Alternativos de Comunicación. Manual de Comunicación Alternativa: sistemas y estrategias. Ediciones Aljibe, S.L (Málaga), España. 2001
37. Vigostki, L.S. Fundamentos de Defectología. Tomo V. Ed. Pueblo y educación, La Habana, 1989.

Anexo #1

Análisis documental

Objetivo: Analizar los documentos que emplea el maestro para el proceso de atención educativa al niño con diagnóstico de sordoceguera.

Aspectos analizar:

- Estado de la caracterización psicopedagógica del niño.
- Precisión de la exploración logopédica con su diagnóstico y estrategia general de intervención.
- La utilización de los sistemas de comunicación aumentativa

Documentos empleados por el maestro:

- Expediente psicopedagógico.
- Expediente logopédico.
- Libreta de comunicación
- Libreta de actividades

Anexo 2

Exploración logopédica para escolares sordociegos de la escuela especial William Soloer Ledea.

Nombre y Apellidos_____

Edad_____

Fecha de realización_____

Programa_____

Nombre del evaluado_____

Cargo_____

Curso_____

Diagnóstico clínico_____

Diagnóstico logopédico _____

Nivel de funcionamiento _____

Comunicación_____

Comunicación expresiva_____

Comunicación receptiva_____

¿Qué sistema de comunicación utiliza para comunicarse?

☐ Lengua oral

☐ Lengua señas

☐ Objetos de referencia.

☐ Pictogramas o dibujos

☐ Expresión facial y/o corporal

☐ Gestos del contexto

☐ Fotografías

☐ Tadoma

☐ Tarjetas en Braille

☐ Braille digital

☐ AMA o dactilema

☐ Escritura en negro

☐ Deletreo táctil

☐ Lengua de señas en campo visual reducido

__ Braille táctil
__ Escritura en la palma de la mano
__ Otros

Evolución del lenguaje _____

Estado Especifico del habla _____

Examen del aparato fonoarticulatorio _____

Estado de la expresión oral _____

Comunicación espontánea _____

Desarrollo del vocabulario _____

Comprensión de órdenes _____

Ejecución de órdenes _____

Comprensión de palabras _____

Ritmo y fluidez del lenguaje _____

Características de la voz _____

Timbre _____ Intensidad _____

Tono _____ Resonancia _____

Calidad de la pronunciación _____

Características de la lectoescritura _____

Estructuras gramaticales _____

Características de la respiración _____

Características de la audición _____

Lectura audio-métrica

OI -----

OD-----

Fecha de la última audiometría _____

Utiliza ayudas técnicas ¿Cuáles? _____

Presenta memoria auditiva

Si _____ no _____

Presenta conciencia auditiva si _____ no _____

Reconoce _____

Identifica _____

Localiza _____

Discrimina _____

Comprende _____

Al escuchar ruidos y/o sonidos como responde al estímulo auditivo

___ Con sobresalto o movimientos corporales (susto)

___ Con llanto

___ Se toca las orejas

___ Cambia su expresión facial

___ Altera su ritmo respiratorio

___ Parpadea o mueve los ojos

___ Cambia el tono muscular

___ Muestra quietud

___ Vocaliza o grita

___ Trata de localizar la fuente sonora

Disfruta de los sonidos que escucha

___ Del ambiente ___ TV ___ Grabaciones

___ verbales ___ onomatopéyicos

Realiza sonidos para su propio placer si___ no___

Es alerta auditivo si___ no___

Utiliza recursos extralingüísticos _____

Visión

Diagnóstico

Es alerta visual

Al presentarle un estímulo lo mira o si al mirarlo lo mira a usted _____

Responde más a

___ colores fuertes

__ contrastes (blanco y negro)

Cuál es la mejor posición para responder al estímulo visual

Mueve los ojos y al moverlos lo hace de manera coordinada

Si__ no__

Tiene referencia de colores

Si__ no__

Sigue con la vista los objetos

Si__ no__

Observa los objetos con funcionalidad si__ no__

Campo visual _____

Agudeza visual _____

Percepción del color forma y profundidad _____

Anexo de la batería de exploración

Reacción auditiva al sonido de instrumentos musicales

Instrumentos Distancia

Bombo -- 1m --- 2m -- 3m --4m --más de 5m

Platillos -- 1m --- 2m -- 3m --4m --más de 5m

Silbato -- 1m --- 2m -- 3m --4m --más de 5m

Tambor -- 1m --- 2m --- 3m --4m --más de 5m

Pandereta -- 1m --- 2m -- 3m --4m --más de 5m

Claves -- 1m --- 2m -- 3m --4m --más de 5m

Filarmónica -- 1m --- 2m -- 3m --4m --más de 5m

Resultados de la audiometría pedagógica

Audiometría tonal _____

Audiometría a campo libre _____

Audiometría verbal _____

Evaluación de la motricidad

Explora los objetos si____ no____

Cuáles objetos prefiere: pequeños____ grandes____

Permanece con los objetos si____ no____

Abre y cierra pomos, cajas si____ no____

Saca objetos de un recipiente si____ no____

Agrupas si____ no____

Utiliza la pinza digital si____ no____

Rasga papelessi____ no____

Garabatea si__ no____

Colorea si____ no____

Conducta observada durante la prueba

Área pedagógica	Área psicológica	Área familiar	Área escolar	Área comunitaria

Anexo 3

Entrevista a maestros y especialistas de la escuela especial William Soler Ledea para personas sordociegas.

Objetivo: Constatar el dominio que tienen los maestros y especialistas de los Sistemas de Comunicación Aumentativa (SCA) empleados en los niños con sordoceguera.

- 1- Refiérase brevemente al conocimiento que posee acerca de los SCA. Mencione al menos tres de ellos.
- 2- ¿Cómo se clasifican estos sistemas y qué valor metodológico le concede a esta clasificación para la práctica pedagógica?
- 3- Según sus vivencias en la especialidad de sordociego, cuáles son las mayores dificultades que se presentan en el empleo de los SCA.
- 4- ¿Considera que el implante coclear es una Estrategia de Comunicación Aumentativa, por qué?
- 5- ¿Cómo orientan a la familia del niño sordociego en la utilización de los SCA?
- 6- Sugiera alguna estrategia de Comunicación Aumentativa para elevar la calidad de vida de las personas sordociegas.

Anexo 4

Guía de observación a diferentes actividades

Objetivo: Observar el uso de las estrategias de comunicación aumentativa en las personas sordociegas.

Indicadores	Descriptores de medida		
	Bastante adecuado	Adecuado	Poco adecuado
Interacción con el otro como mediador.			
Estrategia de comunicación utilizada.			
Adquisición de vivencias por la mediación social-instrumental.			

Criterios de evaluación:

ALTO: Si se cumplen los requerimientos referidos en los cinco aspectos a observar y se constata en los criterios para la concepción del tratamiento el enfoque preventivo, en el que se evidencia el desarrollo ontogenético, el proceso de diagnóstico y la estimulación del desarrollo del lenguaje.

MEDIO: Si se cumplen de manera general al menos tres de aspectos señalados para la observación del tratamiento y se evidencia en la concepción del tratamiento logopédico el enfoque preventivo a partir de la consideración del desarrollo ontogenético.

BAJO: Si se tiene en cuenta el desarrollo ontogenético como parte del trabajo preventivo en los criterios del tratamiento y se cumplen los objetivos propuestos.

Anexo 5

Entrevista realizada a la familia de niños sordociegos de la escuela especial William Soler Ledea.

Objetivo: Buscar información acerca del dominio que tiene la familia sobre el uso de los sistemas de comunicación aumentativa en las personas sordociegas.

- 1- ¿Cómo se comunica con su hijo? Señale algunos ejemplos a partir de la orientación del maestro.
- 2- ¿Qué información tiene acerca de la CA que emplean las personas sordociegas?
- 3- ¿Qué valor le concede al Implante Coclear en la comunicación de las personas sordociegas?
- 4- Refiérase brevemente a las experiencias que tiene en la comunicación con su hijo y lo que ha significado para su desarrollo como persona con discapacidad.

Anexo 6

Estudio de Caso

Caso: I.A.C

Datos generales: FN: 12 de abril del 2006. Edad: 2 años y 4 meses.

Sexo: Femenino. Nacionalidad: Cubana. Procedencia: Urbana.

Diagnóstico clínico: Hipoacusia neurosensorial bilateral profunda con una pérdida auditiva de 95 Db en el OD y más de 120 Db en el OI, acompañado de una ceguera total en ambos ojos. Aspecto distrófico del epitelio pigmentario retineal, palidez papilar, estrechez arterial muy marcada retineal, maculopatía atrófica. Sospechan una Amaurosis congénita.

Es estudiada para descartar algún síndrome (puede ser Leber o Citomegalovirus) Distrofia retineal cono-bastón.

Desarrollo evolutivo a partir de la historia de vida: Embarazo: normal. Parto fisiológico hospitalario término. A las 40 semanas Peso: 8,3 Lbr. Talla: 40cm. Apgar: 9

Desde su nacimiento presenta trastorno del sueño, se irrita con facilidad haciendo manifestaciones de autoagresión y llantos.

Gusta de mantenerse en posición de cúbito supino, presenta retardo en el desarrollo psicomotor: no se sienta, no sostén cefálico, hipotónica. La madre la traslada y la mantiene en coche. Es muy dependiente del otro en todos los procesos.

No tiene control de esfínteres.

Es defensiva táctil. No explora ni se interesa por el medio que le rodea.

Antecedentes patológicos familiares: Familiares sanos. No existe nadie con anterioridad con deficiencias auditivas o visuales.

Vida familiar: vive con su mamá, papá, hermano y abuela. La madre es ingeniera civil pero no trabaja desde que nació la niña. El papá trabaja como Ingeniero civil en la Empresa de proyectos de la construcción en la EMPROY 2. Las condiciones de la vivienda son buenas así como su alimentación y atención, la familia es muy preocupada de la estimulación general de la niña. Se preocupan por llevar a la niña a la escuela y CIS "La Pradera" a recibir estimulación. Su madre está entregada por entero a la atención de la hija.

Anexo 7

Encuesta a especialistas

La encuesta que a continuación le presentamos, tiene como objetivo obtener criterios valorativos sobre las estrategias de comunicación aumentativa para niños sordociegos de la primera infancia.

Esperamos su colaboración para perfeccionar la propuesta educativa.

1. Marque con una (x) su perfil profesional.

☐	Docente de Ed. Especial	☐	Docente de Ed. Integral
☐	Docente en		
	s de experiencia en la atención a escolares sordos que cursan 3ro y 4to grado.		

☐	De 5 a 10 años	☐	De 10 a 15 años	☐	Más de 15 años
--------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	----------------

3. De acuerdo a su experiencia profesional y después de analizar las estrategias de comunicación aumentativa para niños sordociegos de la primera infancia, emita su criterio a partir de los planteamientos que aparecen en la tabla.

Aspectos a valorar	MA	A	PA	NA
Fundamentación				
Estructura y contenido				
Sugerencias metodológicas				

Sus criterios serán altamente valiosos para la tarea de perfeccionamiento.

Muchas gracias por su colaboración.

